

CAT devant une hyperkaliémie :

Diagnostic : = Onde T ample et >pointue

= Hyperkaliémie 5.5 mmol/l

CAT : = Donner immédiatement 1-2 amp de Ca^{+2} de 120mg (si I.renale : à refaire si persistance)

= Selon l'importance de hyperkaliémie : 2càm de Kayexalate dans un grand bol d'eau ou bien sérum glucosé à 30% + 30 UI d'IO ou bien hémodialyse si $\text{K}^{+} > 7$ mmol/l +IRCT

CAT devant un OAP :

Diagnostic : = Dyspnée + râles crépitant

= OAP sur pic hypertensif

= OAP sur cardiopathie + TA normale voir basse

CAT : = Position demi assise

= Oxygénothérapie

= 40mg de lasilix (120mg si IRC) à renouveler 30min ou 1h
si persistance de l'OAP jusqu'à 160mg à 200mg chez un
sujet normal et IRC de 120mg (3-4 fois)

= Faire un ECG + Avis de cardio

➔ ***Si OAP + TA basse :***

= Dobutrex : 2amp dans 250cc de SG à 5% jusqu'à
augmentation de la TA puis lasilix

CAT devant une cétose diabétique :

➔ Selon la glycémie et l'acétonurie

= Gly >2.5g/l ➔ SSI à 9% + électrolytes

= Gly <2.5g/l ➔ SGI à 5% + électrolytes

= Si acétonurie (+) ➔ 10UI (IO) en IV/1h

= Si acétonurie (-) ➔ 10UI (IO) en SC/4h

➔ Les électrolytes : (adapter les résultats surtout si hypokaliémie)

2g de NaCl (1 amp)

1g de KCl ($^{1/2}$ amp)

1g de Mg^{+2} ($^{1/2}$ amp)

1g de Ca^{+2} ($^{1/2}$ amp)

➔ Si signes d'infection ➔ Antibiothérapie :

= Flagyl 500mg/1flacon /8h

= Autres antibiotiques selon type d'infection exp : Claforan /6h

Gly >5g/l (HI) : ➔ CDU = Cetone (-) : 10UI /IV + S^{ce} pd 1h

2.5 < Gly <3.5 : ➔ CDU = Cetone (-) : 10UI /SC + Sce pd 4h

Rentre avec observance du trt et vérifier le régime

Gly >3.5g/l: ➔ CDU = Cetone (-) : 10UI en IVD + S^{ce} chaque 1h

Gly >2.5g/l : ➔ CDU = Cetone (+) : 10UI /IV + SSI + Eléct

(dl.abd, nousées, vo, odeur d'haleine)

Gly <2.5 g/l : ➔ CDU = Cetone (+) : 10UI /IV + SG + Sce 1h

CAT devant un AVC :

Diagnostic : → TA $\geq$ 18/10 (ne pas abaisser la TA avant résultats TDM)

→ Troubles neurologiques

- Aphasie ou Dysarthrie, Céphalées, Flou visuel
- Paralyse faciale centrale ou périphérique
- Déficit moteur : hémiparésie ou hémiplégie

CAT : 1)-Hospitalisation au moins 24 à 48h

2)-Bilan complet : bilan d'urgence, ECG, TA, glycémie

3)-TDM cérébral : objectivant

→ Hyperdensité : AVC hémorragique

→ Hypodensité : AVC ischémique

**TDM cérébral : Normal → suspicion d'AVC ischémique
→ A refaire 48-72h après (l'image va se constituer)**

4)-Surveillance : TA, gly : si patient diabétique

5)-Flash de mannitol : 100cc/8h si AVC ischémique

100cc/6h si AVC hémorragique

N'utilise plus le SGI : risque d'œdème cérébral

Toujours utiliser le SSI à bas débit

Mannitol : on le donne avant 48h

Aspégic : on le donne après 48h

6)-Ordonnance de sortie : ➔ Somazina inj : 1inj/j (relais par

per os= somazina gtt : 2ml*3/j)

➔ Aspégic sachet 100mg: 1sachet/j

(AVC ishémique)

➔ Azantac

7)-Lettres à l'astreinte de neuro-med

AVC hémorragique : abstention thérapeutique pour la TA sauf si >22

AVC ishémique : ↓ la TA mais ne pas dépasser 20% ds le 1^e 24h

CAT devant une convulsion :

➔ Si la 1^e convulsion : = Recherche une hypocalcémie

= AVC

= Troubles ioniques (hyponatrémie, hypoK)

= ECG

➔ Si sujet épileptique connu : = Recherche un écart thérapeutique

= un changement thérapeutique

= une cause, une complication

➔ Si pas de crise : = TDM cérébral + bilan d'urgence

= Garder le pour surveillance.

= Faire un bon interrogatoire

= Avis de neuro-med à l'astreinte

→ Si crise devant nous : = 1 amp de valium dilué en IVL

= 10mg/kg de Gardéнал (dose de charge)

→ Si crise convulsive à répétition et du mal épileptique :

= Amp de valium dilué (0.1mg/kg/j) en IVL

= 10mg/kg de Gardéнал

- Dose de charge pour la $\frac{1}{2}$ 2*/j
- Dose d'entretien pour être efficace

= Canule de Guidel

Suce : si notion de convulsion et pas de convulsion devant nous

Mouillance si épileptique connu

Attention : → il faut éliminer le diagnostic différentiel :

= Hy

= Etat d'agitation

→ Ne donne pas de valium

→ On donne $\frac{1}{2}$ amp de MG+2 dilué en IVL

CAT devant une ingestion de produit caustique :

→ **Bilan radiologique** : Téléthorax + ASP

→ **Si acide** : = Arrêt d'alimentation orale même de l'eau

= Réhydratation : ♠-500cc de SSI à 9 % /2h

♠-500cc de SG à 5% /2h

♠-500cc de sérum bicarbonaté /2h

♠-Électrolytes

= Azantac : 1 amp/4h

= Fibroscopie OGD +++

➔ **Si l'eau de javel ou autres :** = Arrêt d'alimentation

= Réhydratation

= Azantac 1 amp de 150mg /6h

(dose de charge) puis 1 amp 50mg/6h

= Fibroscopie OGD après 48h

(si normale : reprise Altorol)

➔ **Traitement :** trithérapie de l'ulcère ou IPP seul (OMEPRAZOL)

CAT devant un Pic hypertensif :

PAS >21 ou/et PAD >10

➔ *Ne pas abaisser la TA plus de 25%*

➔ *(max : 10cc de loxen /24h + surveillance pendant 15-20min)*

➔ TA $\geq$ 18/10 sans troubles neurologiques :

= 1cc de Loxen dilué dans 1cc de SG à 5% en IVL pendant 3min

= TA toujours augmenter ➔ Même schéma + ECG

= Puis TA augmentée : 20mg de Lasilix

= Ordonnance de sortie : ♠- Profil tensionnel

♠- loxen cp 50mg : 1cp/j

♠- lettre de consultation en cardio

Bilan complet

- FO (pr HTA inaugural)
- Fonction rénale
- Ionogramme sanguin (Na^+ , K^+)
- Chol total, HDL, LDL, TG
- FNS complète
- Fonction hépatique (Protides toraux, TP, Alb, TGO, TGP, phosphatase alcaline, BT et conj)

CAT devant une douleur thoracique :

- ➔TA, Gly, Théléthorax, ECG : Avis de cardio
- ➔ECG normal : ½ amp de Mg^{2+}
- ➔ECG pathologique : Troponine, CPK

CAT devant une hémorragie digestive :

- ➔Bilan d'urgence (surtout HK)
- ➔Si HK <25% = Transfusion
- ➔Présenter le malade à la gastro pour Fibro
- ➔Hospitalisation
- ➔Interrogatoire + Examen clinique + TR + Sonde nasogastrique
- ➔Si saignement actif = lavage par SSI à 9% glacé
- ➔TA basse = Plasmagel en attendant la transfusion
- ➔Si épigastralgie associée = Azantac

➔ Recherche la prise d'anticoagulant ou AVK

➔ Faire TP, INR ==> Avis de cardio

Lieux de consultation :

- Consultation de néphro et uro = 08 mai 1945
- Consultation de cardio = Loussafna
- Consultation de neuro-méd = Astreinte au service + 8 -05 -1945
- Consultation d'endocrino = Astreinte au service +c de santé
- Consultation de gastro = Astreinte au service + ????

Fonction rénale perturbée au bilan ➔ Demander de
néphrologue